

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE PSICOPATÍA DE HARE REVISADA (PCL-R)

Eje III: Personalidad • Evaluación Forense y Clínica de la Psicopatía Mediante Entrevista y Expediente

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Calificación de Psicopatía de Hare Revisada (PCL-R, 2ª edición).
Nombre Original	Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R 2nd Edition; Hare, 1991, 2003).
Autor Original	Dr. Robert D. Hare, Ph.D. (University of British Columbia, Canadá).
Adaptación Hispana	Moltó, Poy y Torrubia (2000); Torrubia et al. (2005); TEA Ediciones (Madrid, España).
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad. Constructo clínico-forense de psicopatía (afecto, interpersonal y antisocial).
Tipo de Instrumento	Escala de juicio clínico/forense de 20 reactivos basada en entrevista semiestructurada y expediente.
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años) en contextos forenses, penitenciarios, psiquiátrico-legales y periciales.
Tiempo de Administración	90 a 120 minutos de entrevista clínica + revisión exhaustiva de antecedentes colaterales.
Régimen de Licencia	Comercial / Restringido (Multi-Health Systems / TEA Ediciones). Nivel C (acreditación pericial).

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CONSTRUCTO DE PSICOPATÍA DE HARE

La **PCL-R** constituye el estándar de oro (**gold standard**) internacional para la evaluación clínica y pericial de la psicopatía. Robert D. Hare sintetizó la tradición nosológica histórica (Cleckley, 1941) con una rigurosa operacionalización psicométrica. El modelo jerárquico tradicional discrimina dos factores ortogonales de orden superior que integran cuatro facetas dimensionales:

- Factor 1 (Interpersonal / Afectivo):** Corresponde al núcleo caracterial primario de la psicopatía. Se asocia neurobiológicamente a hiporreactividad amigdalina, hipoactivación del sistema nervioso autónomo ante señales aversivas y déficit en el condicionamiento del miedo y la empatía emocional vicaria.
- Factor 2 (Desviación Social / Antisocial):** Refleja el componente impulsivo, conductual y transgresor crónico. Se relaciona con hipofunción orbitofrontal y prefrontal ventromedial, falla en la inhibición conductual y reactividad dopaminérgica disfuncional.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (20 ÍTEMS PCL-R)

Factor / Faceta	Ítems	Reactivos Específicos Evaluados en la PCL-R
Factor 1: Interpersonal	4 ítems	1: Locuacidad / encanto superficial; 2: Egocentrismo / grandiosidad; 4: Mentira patológica; 5: Manipulación.
Factor 1: Afectivo	4 ítems	6: Falta de remordimiento o culpa; 7: Afecto superficial; 8: Frialidad / falta de empatía; 16: No asume culpa.
Factor 2: Estilo de Vida	5 ítems	3: Necesidad de estimulación / tedio; 9: Estilo de vida parasitario; 13: Carencia de metas; 14: Impulsividad; 15: Irresponsabilidad.
Factor 2: Antisocial	5 ítems	10: Escaso control conductual; 12: Trastornos de conducta tempranos; 18: Delincuencia juvenil; 19: Quebrantamiento de condena; 20: Versatilidad criminal.
Ítems Adicionales	2 ítems	11: Conducta sexual promiscua; 17: Frecuentes relaciones sentimentales de corta duración.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN FORENSE

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación española de Moltó, Poy y Torrubia (2000; TEA Ediciones) en muestras penitenciarias y periciales confirma una extraordinaria precisión métrica:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Confiabilidad Interjueces	CCI $r = 0.88 - 0.94$	Consistencia casi perfecta entre evaluadores independientes entrenados y acreditados.
Consistencia Interna	Alfa $\alpha = 0.85 - 0.89$	Factor 1 ($\alpha = 0.81$), Factor 2 ($\alpha = 0.83$); homogeneidad factorial robusta.
Validez Predictiva (Violencia)	AUC ROC = $0.76 - 0.84$	Excelente capacidad predictiva de reincidencia violenta y delictiva general a 3 y 5 años.
Validez Convergente	$r = 0.60 - 0.75$	Elevada convergencia con herramientas actuariales de riesgo (VRAG, HCR-20, SVR-20).
Validez Discriminante	$r < 0.20$	Independencia respecto a neuroticismo, ansiedad rasgo y distrés subjetivo internalizante.

5. REGLAS DE CALIFICACIÓN, PONDERACIÓN DE EXPEDIENTE Y CÓMPUTO

- **Sistema Tripartito de Calificación:** Cada uno de los 20 ítems se califica rigurosamente en una escala ordinal de tres niveles:
- **0 puntos (No se aplica):** El rasgo o conducta no está presente, o existen evidencias sólidas que contradicen el criterio.
- **1 punto (Se aplica en cierta medida):** Presencia parcial, ambivalente, o conductas transitorias/inconsistentes a lo largo del ciclo vital.
- **2 puntos (Se aplica con certeza):** El criterio se manifiesta de forma clara, persistente, consistente y documentada en múltiples contextos.
- **Regla de Oro de la Información Colateral:** La entrevista directa nunca se califica aisladamente. Ante discrepancias entre la narrativa del sujeto y las evidencias del expediente judicial/policial, **prevalece siempre la evidencia documental** (debido a la mentira patológica y manipulación).
- **Tratamiento de Ítems Omitidos:** Máximo 5 ítems pueden ser omitidos por falta de información. Se aplica la fórmula de prorrateo oficial:

$$\text{Puntuación Ajustada} = \frac{\text{Suma ítems calificados} \times 20}{\text{Número de ítems calificados}}$$
 Si se omiten > 5 ítems, la escala se invalida.
- **Puntuación Total:** Rango continuo de 0 a 40 puntos.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN FORENSE

Estratificación	Rango PD	Categoría Diagnóstica	Implicación en Riesgo Penitenciario y Recidiva
Bajo	0 a 19 pts	No psicopatía	Bajo riesgo de reincidencia violenta instrumental; pronóstico favorable.
Intermedio	20 a 24 pts	Rasgos psicopáticos moderados	Comportamiento antisocial impulsivo; requiere supervisión estructurada.
Psicopatía (España/UE)	>= 25 pts	Psicopatía clínica validada	Punto de corte validado en España y Europa; alto riesgo instrumental.
Psicopatía (EE.UU.)	>= 30 pts	Psicopatía grave / Extrema	Estándar norteamericano original; violencia predatoria y desensibilización extrema.

PUNTO DE CORTE EN ESPAÑA Y EUROPA (>= 25 PUNTOS):

En baremos penitenciarios españoles y de Europa continental (Moltó et al., 2000; Torrubia et al., 2005), el punto de corte diagnóstico consensuado para psicopatía se establece en **>= 25 puntos**, debido a diferencias transculturales en la manifestación de conductas antisociales institucionales respecto a Norteamérica (corte 30 pts).

APLICACIÓN FORENSE, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN FORENSE, GESTIÓN DEL RIESGO Y MANEJO PENITENCIARIO

PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EN VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA:

- **Paso 1 (Triangulación Documental Exhaustiva):** Realizar el cotejo punto por punto de la entrevista con atestados policiales, sentencias judiciales, informes del centro penitenciario y testimonios de víctimas.
- **Paso 2 (Análisis del Patrón F1 vs. F2):** Determinar si predomina la frialdad instrumental interpersonal (F1 elevado) o la impulsividad reactiva (F2 elevado). Si $F1 > 12$, extremar cautela ante simulación de rehabilitación.
- **Paso 3 (Articulación con Guías Actuariales):** Incorporar la puntuación PCL-R en los protocolos HCR-20 (ítem H7) o SVR-20 (ítem 6) para estimar riesgo dinámico e instrumental de violencia.
- **Paso 4 (Diseño de Planes de Contención):** Contraindicar programas terapéuticos grupales no estructurados o psicodinámicos de insight (evidencia de que sujetos psicópatas utilizan el aprendizaje emocional para perfeccionar la manipulación interpersonal). Pautar supervisión conductual estricta con contingencias inmediatas.

8. CASO CLÍNICO Y PERICIAL FORENSE ILUSTRATIVO: EVALUACIÓN DE RIESGO Y PROGRESIÓN DE GRADO

Identificación: Varón de 39 años interno en centro penitenciario, condenado por homicidio doloso en tentativa y estafas continuadas. La junta de tratamiento solicita peritaje para valorar progresión a tercer grado y concesión de permisos de salida tras solicitud de la defensa alegando “excelente conducta y remordimiento sincero”.

Evaluación PCL-R:

- **Puntuación Total = 31 / 40 puntos** (Diagnóstico confirmado de psicopatía clínica severa; $> 99^{\circ}$ percentil penitenciario).
- **Factor 1 (Afectivo/Interpersonal) = 15 / 16 puntos:** Faceta 1 (Interpersonal) = 8/8 (locuacidad persuasiva, manipulación carismática de educadores); Faceta 2 (Afectiva) = 7/8 (cero empatía hacia la víctima, externalización cínica de la responsabilidad).
- **Factor 2 (Desviación Social) = 14 / 18 puntos:** Faceta 3 (Estilo de vida) = 8/10 (parasitismo, búsqueda de sensaciones); Faceta 4 (Antisocial) = 6/10.
- **Ítems adicionales = 2 / 6 puntos.**

Dictamen Pericial: El análisis del expediente reveló falsificación de justificantes de empleo colateral y tentativas encubiertas de extorsión a otros reclusos mientras simulaba docilidad ante el personal. Se emitió informe desfavorable a permisos penitenciarios por **alto riesgo de reincidencia violenta instrumental y manipulación del sistema judicial**, recomendando mantener régimen cerrado de control.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PSICOPATÍA VS. T. PERSONALIDAD ANTISOCIAL:

El TASP (DSM-5) mide casi exclusivamente transgresiones conductuales (F2). Solo entre el 15% y 25% de los internos con TASP cumplen criterios de psicopatía PCL-R (F1 nuclear). No confundir ambos diagnósticos.

MANIPULACIÓN Y RIESGO PARA EL EVALUADOR:

Sujetos con F1 alto despliegan mimetismo emocional y adulación selectiva. Los evaluadores deben mantener estricto encuadre y verificar cualquier afirmación biográfica con fuentes objetivas externas.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Hare, R. D. (2003). *The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) 2nd Edition: Manual*. Multi-Health Systems.
2. Moltó, J., Poy, R., & Torrubia, R. (2000). Standardization of the Hare Psychopathy Checklist-Revised in a Spanish prison sample. *Journal of Personality Disorders*, 14(1), 34-42.
3. Torrubia, R., Poy, R., & Moltó, J. (2005). *PCL-R: Escala de Calificación de Psicopatía de Hare Revisada. Manual de adaptación al español*. TEA Ediciones.
4. Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2008). Psychopathy as a clinical and empirical construct. *Annual Review of Clinical Psychology*, 4, 217-246.